流行性腮腺炎（Mumps）

一、疾病概述（Disease description）

流行性腮腺炎是急性病毒性疾病，好發於腮腺，有時亦侵舌下腺或顎下腺。

（一）臨床表徵：發燒、頭痛、腮腺（耳下腺）腫大、一個或多個唾液腺腫大且壓痛。

（二）前趨症狀：1～2 天的疲倦、食慾不振，接下來為腮腺疼痛、發燒、喉嚨痛，有時伴隨顎下腺的症狀。

（三）併發症：20～30% 成年男性會併發睪丸炎，多為單側，若為雙側，可能導致不孕；成年女性則可能併發乳腺炎或卵巢炎，但很少會引發不孕症。流行性腮腺炎在早期或晚期可能侵犯中樞神經系統而造成無菌性腦膜炎（Aseptic meningitis）。腦膜腦炎和睪丸炎亦可在唾液腺不被侵犯下發生。其他併發症如胰臟炎及永久神經性耳聾（通常是單側），則較少發生。併發腦炎（Encephalitis）的情形較為罕見，發生率為 1~2/100,000，平均致死率為 1%。曾接種疫苗者如感染，發生併發症的風險則較未曾接種疫苗者低。

（四）懷孕最初 3 個月感染流行性腮腺炎會增加流產的機率，但目前並無肯定的證據顯示懷孕期間感染流行性腮腺炎會導致先天性畸型。

（五）我國自 2006 年起實施流行性腮腺炎通報個案全面採檢，因檢驗確診個案比例低於 1%，且國人 MMR 疫苗接種完成率高，自 2008 年 6 月 1 日起，修訂採檢條件為「符合臨床病例定義且與其他確定或疑似病例有流行病學上之關聯者」才需採檢送驗。為掌握我國流行性腮腺炎流行情形，自2026 年 3 月 1 日起調整通報個案均須進行檢體採檢送驗。

二、致病原（Infectious agent）

副黏液病毒屬（paramyxoviridae）之流行性腮腺炎病毒。

三、流行病學（Epidemiology）

國外資料顯示未接種流行性腮腺炎疫苗之成人中，80% 皆有抗體產生，暴露的人中約有三分之一屬無症狀感染。在未接種疫苗的族群中，感染年齡高峰為 4～9 歲的學齡兒童，大部分小於 2 歲的幼兒感染為沒有明顯症狀的感染。推行疫苗接種後，全球流行性腮腺炎發生率及嚴重併發症大幅降低，病例多發生於青少年與年輕成人。自 2000 年中期起， MMR 疫苗接種完成率高的國家，如美國、英國、紐西蘭、加拿大、荷蘭、西班牙、挪威等，皆曾報告流行性腮腺炎群聚感染事件。研究報

告指出，造成疫苗失敗可能因素，包含病毒抗原變異、疫苗接種產生的免疫力隨時間衰退，以及長時間或頻繁的密切接觸而增加病毒暴露量等。臺灣流行概況詳見衛生福利部疾病管制署「傳染病統計資料查詢系統」。

四、傳染窩（Reservoir）

人。

五、傳染方式（Mode of transmission）

經飛沫及直接接觸感染病人之唾液或呼吸道分泌物傳染。

六、潛伏期（Incubation period）

約 16－18 天 (最短 12 天，最長 25 天)。

七、可傳染期（Period of communicability）

流行性腮腺炎自腮腺腫大發生前 48 小時至發生後 5 日傳染力最強，但發生前 7 天至發生後 9 天可能即具傳染力，發病後 15 天內尿液中仍可能帶病毒。無症狀感染亦具傳染性。

八、感受性及抵抗力（Susceptibility and resistance）

一般人皆可被感染，曾接種疫苗或曾經感染過的人仍可能被感染。流行性腮腺炎一般需要透過密切接觸進行傳播，特別是在曾接種疫苗之族群。

九、病例定義（Case definition）

詳見衛生福利部疾病管制署「傳染病病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項」。

十、檢體採檢送驗事項（Specimens taking and transportation）

自 2026 年 3 月 1 日起，通報個案均須進行檢體採檢送驗。由於血清學檢測結果易受疫苗接種史及其他病原體感染影響，檢驗方式調整以病毒核酸檢驗或病毒培養為主。腮腺炎症狀發生前後之病毒檢驗陽性率最高，隨後迅速下降，因此建議最佳採檢時間點為腮腺腫大發生後之 3 天內。採檢項目為頰腔擦拭液 1 支，冷藏送疾病管制署檢驗及疫苗研製中心進行檢驗。頰腔擦拭液採樣前請先按摩腮腺部位 30秒，再以無菌病毒拭子之棉棒擦拭咽喉兩頰內側腮腺部位，插入病毒保存輸送管。詳細檢體採檢送驗事項請參閱「傳染病檢體採檢手冊」。

十一、防疫措施（Measures of control）

（一）預防接種

1. 可接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR 疫苗），MMR 疫苗接種可在 1 歲後任何時間開始實施。流行性腮腺炎易感宿主應於青春期前完成接種。

2. 我國自 1992 年起針對滿 15 個月之幼兒接種一劑 MMR 疫苗，並於 1992-1994 年及 2001-2004 年間，分別對國三以下學生及國小五年級以下學童陸續進行補種一劑 MMR 疫苗，2001 年 9 月起即針對國小新生常規接種第二劑 MMR 疫苗。自 2006 年起將第一劑 MMR 改為滿 12-15 個月接種，而自 2009 年 4 月起再將第一劑 MMR 改為出生滿 12 個月接種。
3. 現行常規防接種時程：出生滿 12 個月及滿 5 歲至國小入學前各接種一劑 MMR 疫苗。
4. 接種注意事項請見衛生福利部疾病管制署「疫苗簡介」網頁。

（二）病人、接觸者及周遭環境之處理

1. 通報病例：醫師發現符合通報定義之病患時，應於 1 週內通報。通報定義詳見衛生福利部疾病管制署「傳染病病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項」。
2. 檢驗：所有「流行性腮腺炎通報病例」均須進行檢體採檢及送驗。
3. 隔離：自腮腺開始腫大起隔離 5 日，隔離時應採行呼吸道防治措施。
4. 消毒：消毒任何曾受鼻、喉分泌物污染之物品。
5. 檢疫：易感染宿主於暴露後 12～25 天宜避免上學或上班。
6. 疫情調查：所有「流行性腮腺炎通報病例」均須進行疫情調查，了解是否出現聚集事件。
7. 接觸者處理：易感宿主(未曾接種過疫苗或不清楚疫苗史或沒有腮腺炎 IgG 抗體者)於暴露後注射免疫球蛋白並不能預防流行性腮腺炎之發生；易感宿主應接種疫苗，以降低下次被感染之機會。

（三）大流行之措施

易感染宿主應接受預防注射，尤其是可能有暴露感染之虞者，不需以血清學試驗檢測流行性腮腺炎抗體。

流行性腮腺炎之傳染途徑、診斷、檢驗、防治及處置流程

流行病學特徵

1. 急性病毒性疾病
2. 好發於春、冬二季
3. 以 4～9 歲孩童為高峰，成人也會感染
4. 發生前 6～7 日至發生後 9 日為可傳染期

致病因子

流行性腮腺炎病毒

接觸感染

致病因子在唾液或呼吸道分泌物中，以其為媒介感染

飛沫感染

潛伏期：約 12～25 日

症狀

(1)前趨症狀：疲倦、食慾不振、腮腺疼痛、發燒、喉嚨痛、顎下腺症狀

(2) 臨床表徵：發燒、頭痛、腮腺腫大、唾液腺腫大且壓痛

病例定義

一種急性發作，單或雙側腮腺(或其他唾液腺)疼痛，自限性腫脹持續 2 天以上，且無其他明顯原因， 或經實驗室診斷，高度懷疑由 mumps virus 引起。

傳染病防治法 第 39 條規定

1 週內向主管機關報告（第三類傳染病）

傳染病防治法 第 43、44、45 條規定

採取適當防治措施，必要時得隔離治療

併發症	(1)無菌性腦膜炎 (2)腦炎 (3)睪丸炎 (4)卵巢炎 (5)乳腺炎 (6) 神經性耳聾 (7) 胰臟炎
預防	流行性腮腺炎疫苗或 MMR 疫苗
檢查	(1) 所有通報病例皆需進行檢體採檢送驗。 (2) 採檢項目為頰腔擦拭液 1 支，冷藏送疾病管制署檢驗中心進行檢驗。